

Amoebose(Amibiase)

25/11/25

Dr: M.Berbadj
HMRUC

I/Introduction :

- **Parasitose** , largement répandue dans les pays sous développés
- Maladie du péril fécal
- Cliniquement: amoebose **colique/ hépatique**.
- TRT: imidazolés

- Déclaration obligatoire.
- Prévention: respect des règles d'hygiène

II/Epidémiologie:

1.Agent causal :Entamoeba histolytica, protozoaire parasite du **colon** humain.

- On en distingue deux aspects :

.Trophozoïte : forme végétative mobile et de multiplication, présente deux formes :

- **Entamoeba histolytica minuta commensale de l'intestin**
- **Entamoeba histolytica histolytica à pouvoir invasif pathogène.**

.Kyste : immobile, forme de résistance et de contamination.

2. Réservoir naturel:

- L'homme est le seul réservoir du parasite.
- *Entamoeba histolytica* est éliminé dans les selles des sujets parasités sous forme **kystique** très résistante.
- Les kystes survivent plusieurs semaines en milieu extérieur humide.

3. Transmission :

- Péril fécal+++
- **Indirecte:** eaux ou aliments souillés (maladie à transmission hydrique).+++
- **Directe :** maladie des mains sales.

4. Modalités épidémiologiques :

- Cosmopolite,
- Sévit à l'état endémique dans les pays en voie de développement (dont l'Algérie).
- Dans les pays développés, il s'agit d'une maladie d'importation.

III/Physiopathologie :

- **Amoebose infestation:**

kystes ingérés → *Entamoeba histolytica*
minuta (saprophyte de la lumière colique)
→ asymptomatique.

Seules certaines souches auraient une pathogénocité potentielle → invasives

- **Amoebose maladie:** *Entamoeba histolytica*
histolytica (souches invasives).

Les conditions du passage de l'amoebose infestation à amoebose maladie sont mal élucidées.

Physiopathologie:

- **Amoebiose maladie:**

- EHH** envahit la paroi colique
- Portions **cæcale, sigmoïdienne** et **rectale**
- ulcérations → microhémorragies → **tableau de dysenterie non fébrile.**

- EHH** peuvent migrer par voie **portale** vers le foie (**amoebiose hépatique**) : une nécrose tissulaire à l'origine d'abcès.
- EHH** peut franchir le filtre hépatique : amoebiose pleuro pulmonaire.
- Tumeurs inflammatoires coliques (**amoebomes**) avec présence d'amibes au sein de la tumeur.

IV/Etude clinique :

- **amoebose colique**
- **amoebose hépatique**

Amibiase colique :

- **Forme typique :**

Amoebose colique aiguë ou dysenterie amibienne

a-Début: souvent **brutal**, parfois annoncée par une diarrhée banale ou une douleur abdominale.

b-Phase d'état :

Syndrome dysentérique typique

Epreintes+ Ténésme + crachats dysentériques.

Pas de fièvre++++

- **Epreintes:**

Douleurs expulsives violentes à type de coliques débutant au niveau de la fosse iliaque droite, parcourant le cadre colique et se terminant par une envie impérieuse d'aller à la selle.

- **Ténesmes:**

Sensation douloureuse de contracture anale ou parfois seulement une sensation de corps étranger intra-rectal. A l'origine d'émission de selles ou de faux-besoins.

- **Selles** : fréquentes 10-15/jour, typiquement afécales, faites uniquement de glaire muco-purulente et de sang : **crachats dysentériques**

c-Evolution:

- Sous traitement, l'évolution est rapidement favorable.
- **Complications :**
 - **Hémorragies digestives, perforations coliques, abcès péri colique.**
 - Localisations tissulaires à distance : **amibiase hépatique+++**, pleuropulmonaire, cérébrale, péricardique...
 - **Ameobome** : pseudotumeur inflammatoire
 - **Colite chronique** : se manifeste par un syndrome de colopathie fonctionnelle (troubles du transit avec alternance de diarrhée et de constipation, dyspepsie, sensibilité de l'abdomen à la palpation).

Formes cliniques :

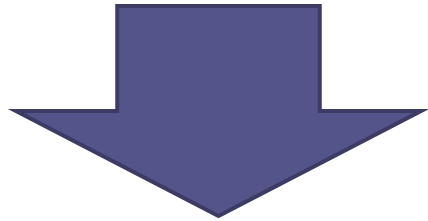
- **Forme atténuée**
- **Amibiase colique suraiguë ou maligne**

Amoebose hépatique

- C'est la plus fréquente des localisations extra coliques.
1. **Douleurs lancinantes de l'hypocondre droit**, irradiant en bretelle vers l'épaule droite.
Il s'agit d'une douleur spontanée, exacerbée par la palpation et l'ébranlement du foie.
 2. **Fièvre élevée à 39 ou 40°C**,
 3. **Hépatomégalie** : Le foie est augmenté de volume, ferme, lisse, douloureux à la palpation avec un bord inférieur mousse.

Triade de Fonton :

Douleur de l'hypocondre droit+ Fièvre élevée+ Hépatomégalie.



Amoebiose hépatique

Amoebose hépatique :

- Parfois, un syndrome **pleuropulmonaire** de la base droite : toux, dyspnée, douleur.
- Rarement est observé **un ictère**, le plus souvent de nature rétentionnelle, suite au développement d'un abcès comprimant la voie biliaire principale.

Evolution :

- Sous traitement, l'évolution est favorable avec disparition de la fièvre et de la douleur en quelques jours avec régression de l'hépatomégalie.
- Complications : augmentation du volume avec risque de rupture dans les organes de voisinage : plèvre, péricarde, péritoine, voies biliaires et la peau.

V/Diagnostic :

- **Diagnostic positif :**

- **Arguments épidémiologiques :** en Algérie, l'amoebose est endémique

- **Arguments cliniques :**

- .Syndrome dysentérique non fébrile.

- .Dans l'amibiase hépatique : hépatomégalie fébrile et douloureuse avec signes de suppuration profonde.

Arguments para cliniques :

- **D'orientation :**

- **Amoebiose colique** : pas de modification de l'hémogramme ni des paramètres inflammatoires

- **Amoebiose hépatique** :

- Hémogramme** : hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile.

- CRP** et **VS** très élevées.

- Radiographie thoracique** : surélévation de la coupole droite avec comblement du cul de-sac costo-diaphragmatique.

- Echographie hépatique** : une ou plusieurs formations liquidiennes arrondies, volontiers polylobées, de taille variable.

- TDM abdominale** : n'est indiquée qu'en cas de forte suspicion clinique lorsque l'échographie n'est pas contributive.

De confirmation:

Amoebiose colique

- **Examen parasitologique des selles** : mise en évidence de formes végétatives d'*Entamoeba histolytica*.
- **Rectoscopie** (si parasitologie négative) : révèle des ulcérations muqueuses « en coups d'ongle », la biopsie permet de retrouver *Entamoeba histolytica* au sein des tissus.
- **Sérologie** : n'a pas d'intérêt dans cette forme.

Amoebiose hépatique

- Recherche des amibes est en règle négative : rare dans les selles, jamais dans les lésions abcédées.
- Le diagnostic repose sur **la sérologie** qui peut ne se positiver qu'après le **7^e jour** de fièvre, parfois même plus tardivement.

Diagnostic différentiel :

Amoebose colique dysentérique

- **Shigellose** : fièvre, altération de l'état général, déshydratation ,
Dg : coproculture, hemocultures
- **Colite pseudomembraneuse** :
prise d'antibiotiques
(lincosamide, β -lactamines)
- **Colite inflammatoire** (Recto-colite Ulcéro-Hémorragique) :
syndrome inflammatoire, signes extradiigestifs.
Diagnostic : histologie

Amoebose hépatique

- **Abcès à pyogènes** : Diagnostic :
ponction, examen bactériologique.
- **Kyste hydatique** infecté :
Diagnostic : sérologie
- **Cancer primitif** du foie :
Diagnostic : biopsie écho-guidée,
histologie

V/Traitement : **Curatif :**

Moyens : imidazolés

➤ **Amoebicide diffusible (tissulaire):**
Métronidazole (Flagyl®) :

Comprimés 250 mg et 500 mg ampoules IV à 500mg
solution buvable

Posologie : 30 mg/kg/j chez l'enfant ; 1,5 à 2 g/j chez
l'adulte.

➤ **Amoebicide de contact (Intetrix®) :**
2 gélules matin et soir pendant 10 jours) pour
éviter les rechutes.

Indications :

- **Amibiase colique :**

Métronidazole (Flagyl®) par voie orale (**PO**).

Durée : 7 à 10 jours.

Ce traitement doit être complété par un amoebicide de contact (Intetrix®)

Amibiase hépatique :

- Métronidazol PO pendant 7 à 10 jours, Complété par un amoebicide de contact.

-Situation habituelle sous notre climat :
hépatomégalie fébrile et douloureuse est très
évocatrice du Dg et justifie un traitement d'épreuve
par nitroamydazolés : Métronidazole par voie
veineuse, complété par un amoebicide de contact.

Suivi :

- ☐ Clinique : fièvre et douleur disparaissent en moins de 3 jours
- ☐ Biologique : CRP, VS.
- ☐ Echographique : se normalise de façon plus lente (2 à 12 mois), cependant il peut persister une image cicatricielle.

Amibiase hépatique :

- La ponction-drainage écho-guidée de l'abcès n'est pas indispensable dans la majorité des cas, mais se justifie :
 - Volumineux proche de la capsule hépatique avec risque de rupture
 - Eliminer un abcès à pyogène
 - Visée antalgique
 - Evolution défavorable

B. Prévention:

- Hygiène+++
- Se laver les mains+++
- Boire de l'eau potable contrôlée+++
- Bien laver fruits et légumes+++.
- MDO.